



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM
MANAJEMEN RISIKO
RS PRIMA HUSADA MALANG**

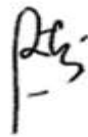
TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Program Manajemen Risiko
Rumah Sakit Prima Husada Malang
Tahun 2026

Disusun oleh:

Ketua Komite PMKP Rumah Sakit Prima Husada



dr. Ari Putriani, Sp.PK

Disetujui oleh:

Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

Ditetapkan oleh:

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Program Manajemen Risiko Rumah Sakit Prima Husada Malang dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Program Manajemen Risiko Rumah Sakit Prima Husada Malang disusun sebagai acuan dan upaya komprehensif untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta memitigasi seluruh risiko strategis maupun operasional guna meningkatkan mutu pelayanan, menjamin keselamatan pasien, staf, serta pemenuhan standar akreditasi rumah sakit.

Program ini akan dievaluasi secara berkala dan dilakukan penyesuaian apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi serta dinamika pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Malang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan segala komitmen dan kerja samanya telah berhasil menyusun program terintegrasi ini.

Malang, 17 Desember 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang padat pakar, padat modal, dan padat teknologi. Kompleksitas pelayanan di rumah sakit yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, interaksi klinis, serta penggunaan sarana prasarana yang tinggi menjadikan rumah sakit sebagai lingkungan yang memiliki tingkat risiko tinggi (*high risk*). Ketidakpastian dan potensi bahaya yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak langsung pada keselamatan pasien, keselamatan staf, kerugian finansial, hingga penurunan reputasi rumah sakit.

Sejalan dengan standar akreditasi rumah sakit (STARKES) dan prinsip keselamatan pasien, manajemen risiko tidak lagi dapat dipandang secara parsial atau terkotak-kotak (*silo*). Rumah Sakit Prima Husada Malang berkomitmen untuk menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi secara makro. Hal ini diwujudkan melalui sinkronisasi data insiden dengan capaian Indikator Mutu Nasional (INM) dan Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS). Selain itu, diperlukan kolaborasi yang erat dan interdisiplin dengan komite lain, seperti Komite K3RS untuk pengelolaan risiko lingkungan kerja, serta Komite PPI untuk pengendalian risiko infeksi rumah sakit.

Tantangan utama dalam implementasi manajemen risiko adalah bagaimana membangun budaya sadar risiko (*risk-aware culture*) di setiap lini pelayanan. Guna mewujudkan keterbukaan dalam pelaporan risiko dan menumbuhkan lingkungan kerja yang adil (*just culture*), diperlukan edukasi berkelanjutan bagi para *Risk Champion*, kepala unit, serta pelaksanaan orientasi bagi pegawai baru. Evaluasi secara berkala melalui survei budaya keselamatan juga menjadi instrumen penting untuk mengukur kesiapan dan pemahaman staf.

Oleh karena itu, sebagai langkah strategis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko secara proaktif, Rumah Sakit Prima Husada Malang menyusun Program Kerja Manajemen Risiko ini. Program ini diharapkan dapat menjadi panduan operasional dalam menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu tinggi, dan berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*).

1.2 Dasar Hukum

- 1.2.1 Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 1.2.2 Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 1.2.3 Peraturan Menteri Kesehatan No 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
- 1.2.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
- 1.2.5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).
- 1.2.6 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1354/2024 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 1.2.7 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
- 1.2.8 Instrumen Survei Akreditasi RS 2024
- 1.2.9 Keputusan Direktorat Jendral No HK.02.02.D.43961.2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Program Manajemen Risiko ini dimaksudkan sebagai panduan strategis dan operasional bagi seluruh jajaran pimpinan, komite, hingga staf di unit pelayanan dalam mengenali, mengevaluasi, serta mengendalikan potensi bahaya secara proaktif dan terintegrasi di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Umum:

Menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu tinggi, dan bebas dari cedera bagi pasien, staf, pengunjung, serta menjaga keberlangsungan operasional

dan reputasi Rumah Sakit Prima Husada Malang melalui implementasi tata kelola risiko yang komprehensif.

Tujuan Khusus:

1. Menghubungkan tren data Insiden Keselamatan Pasien (IKP) dengan capaian Indikator Mutu Nasional (INM) dan Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS).
2. Menyelaraskan dokumen kontrol risiko melalui rapat koordinasi rutin lintas komite, khususnya bersama Komite K3RS (risiko lingkungan/staf) dan Komite PPI (risiko infeksi).
3. Meningkatkan pemahaman staf dan keterbukaan dalam melaporkan risiko (*just culture*) melalui edukasi berkelanjutan bagi para *Risk Champion*, kepala unit, orientasi pegawai baru, serta pelaksanaan survei tahunan budaya keselamatan (*safety culture*).
4. Mengelola dan memitigasi klaim komplain berat atau potensi tuntutan hukum secara cepat dan tepat demi meminimalkan dampak kerugian material maupun immaterial bagi rumah sakit.
5. Memenuhi persyaratan regulasi pemerintah dan instrumen penilaian Akreditasi Rumah Sakit (STARKES), khususnya pada bab Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) serta Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS).

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :
“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

2.2 Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, tepat, cepat, dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

2.3 Motto

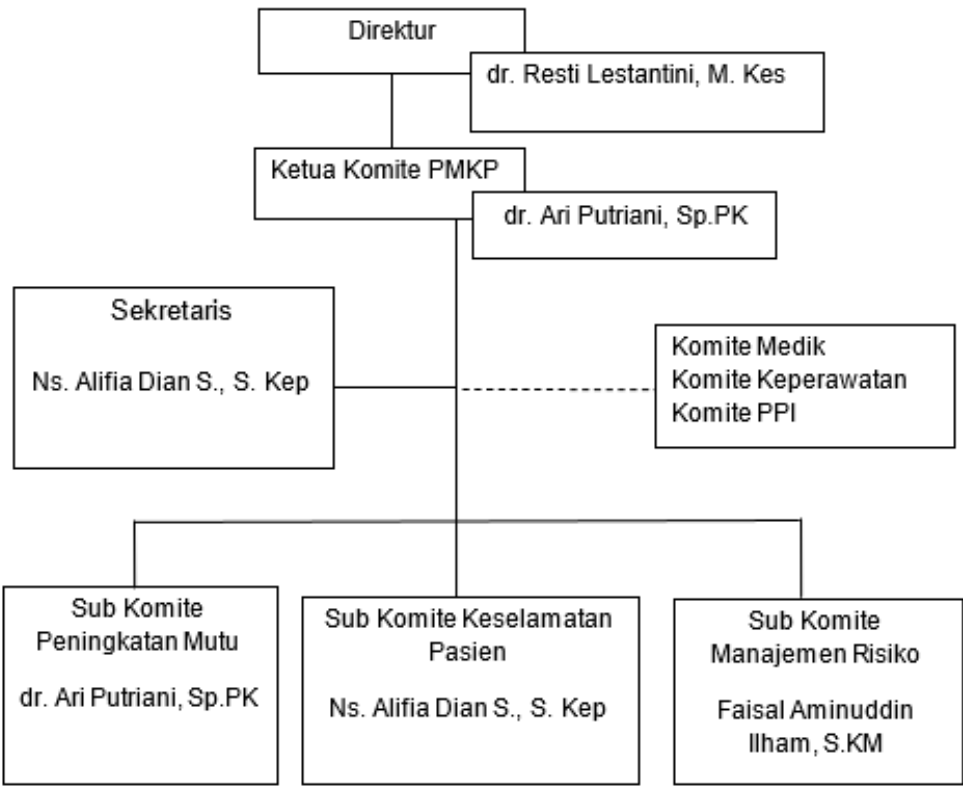
“Sahabat Menuju Sehat”

2.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur dan dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK Komite PMKP



BAB III
KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN POKOK

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1.	Proses Manajemen Risiko	1) Penyusunan daftar risiko (<i>risk register</i>) di seluruh unit 2) Analisis proaktif proses berisiko tinggi (FMEA)
2.	Integrasi Manajemen Risiko di Rumah Sakit	1) Melakukan penyamaan persepsi pengelolaan risiko kepada seluruh unit kerja 2) Melakukan kompilasi dan integrasi <i>Risk Register</i> seluruh unit menjadi <i>Corporate Risk Register</i> (Peta Risiko Rumah Sakit) 3) Melakukan pemetaan, pengelompokan, dan prioritasasi risiko rumah sakit. 4) Menyusun rekomendasi pengendalian risiko prioritas rumah sakit.
3.	Pelaporan Kegiatan Program Manajemen Risiko	1) Mengumpulkan laporan manajemen risiko dari seluruh unit kerja 2) Melakukan analisis hasil identifikasi dan mitigasi risiko yang telah dilaksanakan 3) Menyusun laporan semester program manajemen risiko rumah sakit. 4) Melaporkan hasil kegiatan manajemen risiko kepada Direktur dan Komite Mutu.
4.	Pengelolaan klaim tuntutan yang dapat menyebabkan tuntutan	1) Melakukan identifikasi dan pencatatan kejadian yang berpotensi menimbulkan klaim atau tuntutan. 2) Melakukan investigasi dan analisis kasus terkait klaim atau tuntutan. 3) Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam penyelesaian klaim atau tuntutan. 4) Menyusun rekomendasi perbaikan dan langkah mitigasi untuk mencegah kejadian berulang. 5) Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian klaim atau tuntutan.

[illegible]

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1)	Mengumpulkan laporan manajemen risiko dari seluruh unit kerja	Memantau pelaksanaan manajemen risiko di unit	Seluruh unit kerja	Monitoring	100% unit menyampaikan laporan sesuai jadwal	Persentase unit yang mengirimkan laporan	
2)	Melakukan analisis hasil identifikasi dan mitigasi risiko yang telah dilaksanakan	Menilai efektivitas pengendalian risiko yang telah dilakukan	Risiko yang telah dimitigasi	Evaluasi	Dilaksanakan setiap semester	Tersedianya hasil analisis dan evaluasi risiko	
3)	Menyusun laporan semester program manajemen risiko rumah sakit	Menyediakan informasi pelaksanaan program manajemen risiko	Direktur dan Komite Mutu	Pelaporan	Laporan Semester	Laporan semester tersusun tepat waktu	
4)	Melaporkan hasil kegiatan manajemen risiko kepada Direktur dan Komite Mutu.	Mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko	Direktur dan Komite Mutu	Pelaporan	100% laporan disampaikan sesuai jadwal	Bukti penyampaian laporan kepada pimpinan	
4.	Pengelolaan klaim tuntutan yang dapat menyebabkan tuntutan						
1)	Melakukan identifikasi dan pencatatan kejadian yang berpotensi menimbulkan klaim atau tuntutan	Mendeteksi dini potensi klaim dan tuntutan	Seluruh kasus yang berpotensi menimbulkan klaim	Manajemen Risiko	100% kasus terdokumentasi	Persentase kasus yang tercatat dalam register	
2)	Melakukan investigasi dan analisis kasus terkait klaim atau tuntutan	Mengetahui akar masalah dan faktor penyebab	Kasus klaim atau tuntutan	Investigasi	100% kasus dilakukan analisis	Laporan investigasi tersedia	
3)	Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam penyelesaian klaim atau tuntutan	Memastikan penanganan kasus berjalan efektif	Unit terkait dan manajemen rumah sakit	Koordinasi	100% kasus ditindaklanjuti	Bukti rapat/koordinasi dan tindak lanjut	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
4)	Menyusun rekomendasi perbaikan dan langkah mitigasi untuk mencegah kejadian berulang	Mencegah terulangnya kejadian serupa	Kasus yang telah dianalisis	Perbaikan Mutu	100% kasus memiliki rekomendasi	Persentase kasus yang memiliki rekomendasi perbaikan	
5)	Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian klaim atau tuntutan.	Menilai efektivitas tindakan perbaikan	Tindak lanjut hasil investigasi	Monitoring dan Evaluasi	≥80% tindak lanjut selesai sesuai rencana	Persentase tindak lanjut yang telah diselesaikan	

[illegible]

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1)	Mengumpulkan laporan manajemen risiko dari seluruh unit kerja	Merekap laporan pelaksanaan manajemen risiko dari setiap unit	Monitoring dan rekapitulasi	Form laporan manajemen risiko	Semester I-II	Rekap laporan unit	
2)	Melakukan analisis hasil identifikasi dan mitigasi risiko yang telah dilaksanakan	Menelaah efektivitas tindakan pengendalian dan mitigasi yang telah dilakukan unit	Evaluasi dan analisis data	Laporan risiko unit	Semester I-II	Hasil analisis dan evaluasi risiko	
3)	Menyusun laporan semester program manajemen risiko rumah sakit	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan manajemen risiko rumah sakit	Kompilasi dan analisis data	Format laporan program	Semester I-II	Laporan semester manajemen risiko	
4)	Melaporkan hasil kegiatan manajemen risiko kepada Direktur dan Komite Mutu.	Menyampaikan hasil pelaksanaan dan evaluasi program kepada pimpinan rumah sakit	Presentasi dan pelaporan	Laporan dan bahan presentasi	Semester I-II	Laporan Semester Manajemen Risiko	
4	Pengelolaan klaim tuntutan yang dapat menyebabkan tuntutan						
1)	Melakukan identifikasi dan pencatatan kejadian yang berpotensi menimbulkan klaim atau tuntutan	Mencatat dan mendokumentasikan seluruh kejadian yang berpotensi menimbulkan klaim	Monitoring dan pelaporan	Form pencatatan kasus (SIMRS)	Insidental	Register klaim/tuntutan	
2)	Melakukan investigasi dan analisis kasus terkait klaim atau tuntutan	Melakukan investigasi dan analisis penyebab kejadian	Investigasi, RCA, wawancara	Form investigasi, dokumen pendukung	Insidental	Laporan investigasi	
3)	Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam penyelesaian klaim atau tuntutan	Melakukan rapat koordinasi dan pembahasan tindak lanjut penyelesaian kasus	Koordinasi dan diskusi	Notulen rapat, dokumen kasus	Insidental	Notulen dan hasil koordinasi	
4)	Menyusun rekomendasi perbaikan dan langkah mitigasi untuk mencegah kejadian berulang	Menyusun tindakan korektif dan preventif berdasarkan hasil investigasi	Analisis dan perencanaan perbaikan	Form RTL dan rekomendasi	Insidental	Dokumen rekomendasi dan RTL	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
5)	Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian klaim atau tuntutan.	Memantau pelaksanaan rekomendasi dan mengevaluasi efektivitas perbaikan	Monitoring dan evaluasi	Form monitoring RTL	Semester I-II	Laporan monitoring dan evaluasi	

3.4
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Proses Manajemen Risiko																	
1)	Penyusunan daftar risiko (<i>risk register</i>) di seluruh unit	Seluruh unit kerja												√	Unit kerja masing-masing	Komite PMKP	PT.DPM	
2)	Analisis proaktif proses berisiko tinggi menggunakan metode FMEA	Proses berisiko tinggi												√	Ruang rapat/Zoom Meeting	Komite PMKP & Tim FMEA	PT.DPM	
2.	Integrasi Manajemen Risiko di Rumah Sakit																	
1)	Melakukan penyamaan persepsi pengelolaan risiko kepada seluruh unit kerja	Kepala unit dan PIC Mitigasi Risiko												√	Ruang rapat/Zoom Meeting	Komite PMKP	PT DPM	
2)	Melakukan kompilasi dan integrasi <i>Risk Register</i> seluruh unit menjadi <i>Corporate Risk Register</i> (Peta Risiko Rumah Sakit)	Seluruh risiko unit												√	RS	Komite PMKP	PT.DPM	

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3)	Melakukan pemetaan, pengelompokan, dan prioritasasi risiko rumah sakit.	Risiko prioritas RS												√	RS	Komite PMKP	PT.DPM	
4)	Menyusun rekomendasi pengendalian risiko prioritas rumah sakit	Risiko prioritas RS												√	RS	Komite PMKP dan Unit terkait	PT.DPM	
3	Pelaporan Kegiatan Program Manajemen Risiko																	
1)	Mengumpulkan laporan manajemen risiko dari seluruh unit kerja	Seluruh unit kerja						√							RS	Komite PMKP	PT DPM	
2)	Melakukan analisis hasil identifikasi dan mitigasi risiko yang telah dilaksanakan	Risiko yang telah dimitigasi						√							RS	Komite PMKP	PT DPM	
3)	Menyusun laporan semester program manajemen risiko rumah sakit	Direktur dan Komite Mutu						√							RS	Komite PMKP	PT DPM	
4)	Melaporkan hasil kegiatan manajemen risiko kepada Direktur dan Komite Mutu.	Direktur dan Komite Mutu						√							RS	Komite PMKP	PT DPM	
4	Pengelolaan klaim tuntutan yang dapat menyebabkan tuntutan																	
1)	Melakukan identifikasi dan pencatatan kejadian yang	Seluruh unit kerja												√	Seluruh unit kerja	Komite PMKP dan	PT DPM	

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	berpotensi menimbulkan klaim atau tuntutan															Unit terkait		
2)	Melakukan investigasi dan analisis kasus terkait klaim atau tuntutan	Kasus yang terjadi	Insidental												Ruang rapat	Tim Investi gasi	PT DPM	
3)	Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam penyelesaian klaim atau tuntutan	Unit terkait	Insidental												Ruang rapat	Komite PMKP dan Manaj emen	PT DPM	
4)	Menyusun rekomendasi perbaikan dan langkah mitigasi untuk mencegah kejadian berulang	Kasus yang telah dianalisis	Insidental												Ruang rapat	Tim investi gasi	PT DPM	
5)	Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian klaim atau tuntutan.	Tindak lanjut perbaikan	Insidental												Unit terkait	Komite PMKP	PT DPM	

1.5 Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah disetujui oleh PT. Disa Prima Medika dengan rincian sebagaimana terlampir :

Tabel 3.5. Kebutuhan biaya pengembangan SDM Komite PMKP tahun 2026

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
1	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	Eksternal	2	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000
2	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Eksternal	2	Rp 3.500.000	Rp 7.000.000
3	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Eksternal	1	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
4	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Malang	Internal	3	Rp 20.000	Rp 60.000
5	<i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: a. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit b. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien c. Budaya Keselamatan d. Manajemen Resiko	Internal	3	Rp 20.000	Rp 60.000
7	Pelatihan Pengambilan Data Mutu	Internal	2	Rp 20.000	Rp 40.000

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
	Materi: a. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit b. Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS c. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan d. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS e. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS				
8	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: a. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit b. Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	Internal	2	Rp 20.000	Rp 40.000
9	Honorarium narasumber pelatihan insidentil (DPJP) 4 kali pelatihan x 4 org DPJP	Eksternal	20	Rp 250.000	Rp 5.000.000
TOTAL					Rp 24.200.000

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

1.1. Monitoring

- a. Monitoring dilakukan secara berkesinambungan (proses berjalan) selama tahun anggaran untuk memantau ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan (timeline), kendala operasional di lapangan, serta serapan indikator yang telah direncanakan, dengan metode monitoring :
- b. Rapat Koordinasi Bulanan:
- c. Subkomite Manajemen Risiko menyelenggarakan pertemuan berkala dengan para Risk Champion unit untuk memantau progres pengisian Risk Register dan tindak lanjut Action Plan.
- d. Sensus Laporan Insiden:
- e. Melakukan pemantauan harian terhadap sistem pelaporan insiden guna memastikan tidak ada insiden kategori kuning/merah yang terlewat dari proses RCA.
- f. Audit Kepatuhan Lapangan:
- g. Melakukan telaah acak (sampling) ke unit kerja untuk melihat kepatuhan pengisian dokumen klinis ERM serta kontrol risiko fasilitas

1.2. Evaluasi

Evaluasi program kerja Manajemen Risiko diukur berdasarkan pemenuhan target sasaran sebagai berikut:

1. Evaluasi Proses Manajemen Risiko:
 - Penilaian terhadap persentase unit kerja yang mengumpulkan dan memperbarui Risk Register (Target: 100%).
 - Evaluasi ketepatan waktu penyelesaian RCA (Target: 45 hari) dan Investigasi Sederhana (Target: 7–14 hari)
 - Penilaian keberhasilan pelaksanaan FMEA minimal 1 kali dalam setahun.
2. Evaluasi Integrasi Manajemen Risiko:
 - Mengukur tingkat kelulusan pasca-tes (post-test) staf pada pelatihan kesadaran risiko (Target nilai: >75).
 - Analisis hasil Survei Budaya Keselamatan Pasien untuk mengukur peningkatan indeks keterbukaan staf (just culture) dibanding tahun sebelumnya.
3. Evaluasi Dampak Mitigasi (Re-Scoring):
 - Melakukan skoring ulang terhadap risiko-risiko ekstrem/tinggi yang ada di Risk Register Korporat di akhir tahun. Evaluasi dinyatakan berhasil jika tindakan mitigasi mampu menurunkan grading risiko (misal: dari Merah menjadi Kuning/Hijau).
4. Evaluasi Pengelolaan Klaim Tuntutan:
 - Menilai persentase kelengkapan rekam medis dan informed consent (Target: > 95%-100%).
 - Memastikan tingkat penyelesaian komplain medikolegal di tingkat internal mencapai 100% (tidak ada yang berlanjut menjadi tuntutan hukum/pidana/perdata)

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

5.1 Pencatatan

Pencatatan adalah aktivitas mendokumentasikan setiap tahapan proses manajemen risiko, mulai dari temuan lapangan, analisis, hingga hasil akhir mitigasi di tingkat unit maupun Rumah Sakit.

1. Lembar Risk Register (Unit & Korporat):
Berisi daftar risiko yang teridentifikasi, skor dampak dan probabilitas awal, rencana mitigasi (action plan), serta skor risiko setelah mitigasi.
2. Formulir Laporan Insiden (Internal):
Formulir standar 2×24 jam yang diisi oleh staf/kepala unit saat terjadi Insiden Keselamatan Pasien (IKP), insiden K3, atau kejadian kerusakan fasilitas.
3. Lembar Kerja Investigasi & RCA:
Berisi kronologis insiden, hasil wawancara, analisis akar masalah (menggunakan Fishbone Diagram atau 5 Whys), dan rekomendasi tim interdisiplin.
4. Dokumen Medikolegal:
Rekam medis pasien yang terisi lengkap, berkas Informed Consent, serta berkas kronologis keluhan/komplain medik dari Humas.
5. Dokumen Pendukung Administrasi (NJPD):
Berupa Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat, dan Dokumentasi Foto dari setiap rapat koordinasi, FMEA, maupun sosialisasi.

5.2 Pelaporan

Sistem pelaporan dibagi menjadi dua kategori berdasarkan sifat kejadiannya:

Laporan Rutin Berkala :

1. Laporan Bulanan:
Rekapitulasi jumlah insiden, tren komplain, dan progres mitigasi dari unit kerja kepada Subkomite Manajemen Risiko setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
2. Triwulanan:
Laporan komprehensif dari Ketua Komite Mutu kepada Direktur Rumah Sakit mengenai Profil Risiko terkini, progres FMEA, dan efektivitas pengendalian risiko.
3. Laporan Semesteran & Tahunan:
Laporan makro dari Direktur Rumah Sakit yang disampaikan kepada Dewan Pengawas (Representasi Pemilik) sebagai bentuk pertanggungjawaban tata kelola tata klinis dan non-klinis yang aman.

Laporan Insidental (Segera):

1. Jika terjadi Kejadian Sentinel atau insiden dengan risk grading Merah / Ekstrem, Kepala Unit wajib melaporkan secara lisan secara instan, diikuti laporan tertulis dalam waktu maksimal 2×24 jam kepada Komite Mutu dan Direktur.
2. Direktur selanjutnya melaporkan kejadian sentinel tersebut kepada Pemilik/Dewan Pengawas dalam waktu maksimal 2×24 jam untuk koordinasi langkah hukum atau mitigasi reputasi.

BAB VI
PENUTUP

Demikian program kerja Manajemen Risiko disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Malang tahun 2026. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang terlaksananya program kerja yang sudah disusun.

Mengetahui
Ketua Komite PMKP



dr. Ari Putriani, Sp.PK

Malang, 17 Desember 2025
Menyetujui,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestianti, M.Kes